

临床药师对药物相互作用问题认识的思考

何咏梅,徐玉,张坤菊

(贵州省黔西南州中医医院药剂科,贵州 兴义 562400)

摘要:目的 为药师开展临床药学服务工作提供参考。方法 调查分析我国基层医院开展药学服务方面存在的问题,并分析我国医院用药中药物相互作用方面存在的问题。结果与结论 临床药师开展药学服务工作,只有找准工作目标、恰当定位,才能深入临床,与医护人员优势互补,切实了解实际用药情况,提供高附加值的药学服务。

关键词: 临床药师; 药学服务; 药物相互作用; 问题; 思考

中图分类号: R969.2; R952

文献标识码: C

文章编号: 1006-4931(2011)20-0064-02

随着临床药学的深入开展,基层医院也逐渐推行临床药师制。笔者从我院开展临床药学服务中遇到的实际困难出发,查阅分析我国基层医院开展药学服务存在的问题,从临床药师开展工作的切入点选择方面,以药物相互作用为工作的重点进行总结,希望可以此为刚起步于临床药学服务的同行提供参考。

1 基层医院开展药学服务存在的问题

当前,基层医院开展临床药学工作受人才、设备、观念等方面的制约,各医院在管理模式、工作方法、深入程度方面参差不齐。

基层医院在临床药学服务方面起步较晚,药房长期以医药品保管和发放为工作中心的传统观念,使得有些药师难以接受以患者为中心的转变。基层医院药学期长期脱离临床,工作处于被动状态,重医轻药状态普遍存在。

一些基层医院既没有血药浓度监测仪器,也没有较好的药理实验条件,更没有临床药学工作的专门人才,这就导致基层医院临床药学工作难以开展。此外,临床药师专业技术水平有限,高素质专业人才欠缺,不能满足临床开展合理用药工作的需要。

由于医护人员及患者对临床药师直接干预药疗的认识不足、缺乏理解,药师在提出和纠正不合理用药问题时,医护人员往往会出现抵触和反感情绪,患者和药师之间缺乏建立相互信任关系的环境氛围,使得药患沟通也难以展开。

2 药物相互作用研究进展

药物相互作用是指药物的药效受到配伍应用的药物(或事先事后应用的其他药物)、内源性物质、附加剂、食物等影响而发生变化的现象。这里的变化不仅包括疗效的性质、强度、持续时间、副作用、毒性的变化,而且包括对临床和检验、体液药物浓度测定等的干扰。这种相互作用不仅限于用药过程中,也包括发生于用药后某一时间内所发生的相互影响。药物相互作用涉及面很广,不仅需要药剂学知识,还要有生理学、药理学、药物治疗学、生物化学、药物动力学和药理学等多方面知识。

近几年,致死性药物相互作用时有报告^[1],如三唑仑与阿米替林、氟西汀与氯氮平、喷司他丁(酶抑制剂)与环磷酰胺等。发生在体内的、代谢性相互作用,已引起人们的高度重视,但这是用体外实验方法来验证体内代谢过程的相互作用,以往只能做到定性水平。随着对药物代谢分子水平的认识和体外研究技术的进步,目前已能成功预测或评估体内发生的一些药物相互作用。

调查表明,在住院患者中,每日用药1~5种,潜在药物相互作用发生率为12.1%,实际药品不良反应(ADR)发生率为3.5%;用药6~10种,潜在相互作用发生率为29.0%,实际药品不良反应发生率为10.0%;用药11~15种,潜在相互作用发生率为44.8%,实际药品不良反应发生率为28.0%^[2]。每年因药物相互作用的致死率,占住院患者致死原因的4~6位。因此,应提高对药物相互作用的认知。

3 存在药物相互作用问题的原因

尽管药物相互作用发生率很高,但有临床症状或意义的药物相互作用发生率相对较低。而且,药物相互作用的临床表现通常以药品不良反应的形式出现,易被普通的药品不良反应现象所掩盖;药源性损害的临床表现被疾病的临床症状所掩盖,可因患者服用的其他药物所改善或缓解。因此,药物相互作用往往不能引起重视。

随着医学发展,分科越来越细。在三级以上大医院,往往以器官、系统分科,科内又分专业小组,各专科医师之间交流、沟通很少,尤其是中医和西医之间,相互交流和沟通很少。患者多科看病,各科开各科的药,容易导致药物相互作用。

目前,我国住院患者平均每日合并用药5种,不合理用药发生率达21.8%,相对于其他国家,我国医师用药量偏大^[3]。笔者认为,其动因与处方者(医师)在我国医疗体系中拥有用药决定权,且受经济利益驱动有关。

随着医院药学服务模式的改变,药师已从窗口后面走了出来,由单纯发药转变为直接面向患者服务。但目前我国临床药师非常缺乏,且一些药师自身学识不够,无法指导患者用药,加之新药层出不穷,日常工作应接不暇,这也使临床药学工作增加了难度。

由于我国临床药师缺乏,药物相互作用研究起步晚,当遇到由药物相互作用引发的药品不良反应时,往往由医师而非临床药师来判断,所以一般会误以为是病情所致。究其原因,一是医师因专业限制无法承担合理用药指导工作;二是现行药物相互作用的研无法跟上新药的出现速度。

随着中西医结合的深入发展,中西药联用治疗疾病已成为重要的治疗手段并日益增多,但中西药合用同样面临药物相互作用,需引起重视。

4 临床药师开展以药物相互作用为主线的药学服务

在疾病的治疗过程中,临床医师处于主导地位,他们虽然熟知药物的适应证和使用方法,但对药物的结构、性质等却了解不多,尤其是新药的不断涌现,其作用机制、毒副作用对临床应用是一道难题。因此,药师可以充分利用自身所掌握的知识,帮助医师们解决一些难题,共同商榷用药方案。

多种基础疾病共存,可导致临床联合用药普遍化和常规化,药物相互作用问题将成为临床日益关注的突出问题。由于专业和工作性质的局限性,医师对药物的药理作用、药动学和药效学等知识疏于了解,从而易忽略临床潜在的药物相互作用,而这些恰好是临床药师的专长。临床药师应开展以药物相互作用为主线的药学服务,在熟练掌握专业选向范围内药品的相关知识及其理论的前提下,还应着重学习药物相互作用的知识。在临床的药学服务工作中,要注意潜在的药物相互作用,并有针对性地了解患者病情和各

实施品管圈活动降低中心药房调剂差错率的成效分析

蔡雪桃,陈文伟,卢结文,陈 芳

(广东省佛山市第一人民医院,广东 佛山 528000)

摘要:目的 利用品管圈,组成中心药房质量改善圈,降低中心药房调剂差错率,提升药房服务水平。方法 将品管圈活动应用于中心药房药品调剂质量控制,及时分析差错原因,制订相应对策并实施。结果 调剂差错率在实施品管圈活动后下降了 50.51%。结论 在实际工作中恰当运用质量管理方法,能够不断发现和解决药房存在的问题,改善药房品质和服务水平。

关键词:品管圈;调剂;差错;药房

中图分类号: R952 文献标识码: A

文章编号: 1006-4931(2011)20-0065-02

品管圈(quality control circle,QCC)是由工作在同一现场的人员,自动自发地进行品质管制而组成的小组,在自我启发和相互启发的原则下,灵活运用各种统计方法,以全员参与的方式不断进行维护及改善工作现场。我院为三级甲等医院,每天调剂药品约 2 000 多人次,本项目组通过品管圈活动,分析影响中心药房调剂差错率的主要因素,提出和实施改进的方法,以提高中心药房工作质量、降低中心药房调配剂差错率。

1 方法

1.1 成立品管圈和确定主题

由辅导员、圈长、圈员等 7 人组成中心药房“品管圈”,圈名为蜜蜂圈,辅导员为药剂科负责人,圈长为 中心药房负责人。经全体圈员反复讨论,达成共识,确定“降低中心药房调剂差错率”为活动主题。

1.2 活动计划及方法

整个品管圈活动历时 6 个月,每星期活动 1 次,每次 1.5 h。第 1 月介绍品管圈课程,推选圈长,确定圈名及圈徽;第 2 月选定主题;第 3 月拟订活动计划,把握现状;第 4 设定并解析目标;第 5 月拟订对实施与检讨对策,并对效果加以确认;第 6 月对相关指标标准化,进行检讨与改进,最后整理资料。

1.3 目标设定

以“降低中心药房调剂差错率”为活动主题,通过对实施品管圈活动前后的差错发生率进行记录跟踪,设定目标值。按下列计算公式为:目标值=现况值-改善值=现况值-(现况值×圈能力)。目标值设定:如中心药房活动前调剂差错率为 0.97%,目标值为 0.49%,拟订圈能力为 50%。本项目的差错主要指内差,界定标准为:调剂药品过程中发生、但配发给患者前已被纠正的差错,如数量错误、规格错误、用法用量错误、品名或包装引发的差错等。

1.4 找出问题

根据我院药品调剂及配送流程,找出易发生问题之处方作为

种检验检查结果的变化,以及及时发现和解决问题。

全球约有 1/3 的患者死于不合理用药,而非疾病本身^[3]。因药物相互作用而引发不合理用药,不仅违反合理用药原则,还造成国家医药资源的极大浪费,而且可能引发医疗纠纷。因此,不仅要思想上加强防范意识,更重要的是要加强药物相互作用相关专业知识的学习,加强对新药的药理、药效学特性的学习,并注意相关学科知识。

2002 年卫生部《医疗机构药事管理暂行规定》第 17 条规定,我国将逐步建立临床药师制,这为我国医院临床合理用药提供了制度保障。随着临床药学服务的制度变化,其相应临床学服务模式也需重构。在新的临床药学服务模式下,临床药师应深入临床一线,与医师共同探讨用药方案和药物相互作用等问题,并加强与医师、护士和患者沟通,共同做好合理用药工作。为此,临床药师需加强

实施质量控制的关键点,摒弃传统权威式的会议形式,通过因果分析,发现中心药房配剂差错主要产生在审核医嘱、打印医嘱、调剂总数、病房清点、药品上架等方面,原因主要是审核不严、打印漏单、药品包装相似、药品数量拿错、病房护士清点时数量出错、发放贵重药品未及时登记等。将实施品管圈活动前后的差错发生率作记录并比较。

1.5 对策实施

针对问题,制订解决方案并进行具体实施,分工落实到每一位圈员。实施过程中出现问题,及时调整对策予以解决,药管圈活动前后差错情况见表 1。

表 1 品管圈活动前后差错情况

差错原因	活动前例数	活动后例数
医嘱审核不严	5	2
打印漏单	4	2
药品名称及包装相似导致品种拿错	14	9
进口、国产不分拿错	8	4
药品数量拿错	25	12
高危药品没分区摆放导致品种拿错	11	5
规格剂量调剂错误	20	11
病房护士清点时数量出错	10	3

注:活动前后例数指每 10 000 例中发生例数。

2 结果

2.1 有形成果

实施药管圈活动前差错率为 0.97%。实施品管圈活动后,差错率为 0.48%,差错率下降了 50.51%。

2.2 无形成果

评价项目:沟通能力,责任心,和谐程度,荣誉感,团队精神,品管手法,工作效率,解决问题的能力。

评价方式:由圈员 8 人以自评方式评分,每项每人最高 5 分,

学习,不但要熟悉和掌握药物的各种性能及其相互作用知识,还要努力学习临床医学知识和心理学、经济学等知识。在我院临床科室的工作实践中,笔者体会到,在日常工作中应将药物相互作用作为重点关注的问题之一,及时总结经验,提高专业技能,与医护人员优势互补,以做好临床药学服务。

参考文献:

- [1] Yuan R, Parmelee T, Balian JD, et al. In vitro metabolic interaction studies: Experience of the Food and drug Administration[J]. Clinical Pharmacology Therapeutics, 1999,66(1): 9-15.
- [2] 周元瑶. 药物流行病学[M]. 北京:中国医药科技出版社,1996: 5.
- [3] 柯元南. 重视药物相互作用,保证用药安全[J]. 中日友好医院学报, 2006,20(1): 3.

(收稿日期: 2010-12-29)